

Castres, le 15 Juin 2026

COMPTE-RENDU D'HOSPITALISATION

PATIENT :

Nom : DUPONT Jean

Date de naissance : 14/03/1964 (62 ans)

Sexe : Masculin

MOTIF DE L'ADMISSION :

Monsieur Jean Dupont a été admis en urgence dans notre service le 14 juin 2026 pour la prise en charge d'une douleur thoracique aiguë d'apparition brutale, irradiant dans le bras gauche, accompagnée de sueurs profuses.

HISTOIRE DE LA MALADIE & EXAMEN CLINIQUE :

Le patient décrit une douleur constrictive "en étau" rétrosternale survenue au repos vers 08h00 du matin. Devant la persistance des symptômes, l'entourage a contacté le SAMU.

À l'arrivée des secours, les constantes étaient les suivantes :

- Pression artérielle : 155/90 mmHg
- Fréquence cardiaque : 92 bpm
- Saturation en oxygène : 94% à l'air libre

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :

1. Électrocardiogramme (ECG) : Met en évidence un sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures (V2, V3, V4), évocateur d'un infarctus du myocarde aigu (syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST - STEMI).
2. Biologie : Élévation significative de la troponine cardiaque (I) à 1500 ng/L (N < 14 ng/L), confirmant la nécrose myocardique.

PRISE EN CHARGE & ÉVOLUTION :

Le patient a été transféré immédiatement en salle de cathétérisme pour une coronarographie d'urgence. L'examen a révélé une occlusion thrombotique aiguë de l'artère interventriculaire antérieure (IVA).

Il a été procédé avec succès à une angioplastie primaire avec mise en place d'un stent actif.

L'évolution clinique est favorable ce jour (J1). La douleur thoracique a totalement disparu. Les paramètres hémodynamiques sont stables.

CONCLUSION :

Infarctus du myocarde antérieur aigu pris en charge à la 2ème heure par angioplastie primaire et pose de stent. Évolution initiale favorable.

Dr. A. Martin, Cardiologue